

Meme Kanseri Klinik Evreleme Rehberi

Hasta Dostu Kapsamli Bilgilendirme Dokumanı

Tümör Boyutu • TNM Evrelemesi • Hormon Reseptörleri • Lenf Nodu Analizi

Hasta Ornegi — Incelenen Degerler

Tumor Boyutu	25 mm
T Evresi	T1
N Evresi	N1
6th Evre	IIA
A Evresi	Regional
Grade	1
Diferansiyasyon	Well Differentiated
Ostrojen	Pozitif (+)
Progesteron	Pozitif (+)
Incelenen Lenf Nodu	10
Pozitif Lenf Nodu	2

Bu belge yalnızca eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi kararları mutlaka uzman hekim tarafından verilmelidir.

İçindekiler

1. Tümör Boyutu (mm)
2. T Evresi — Tümörün Lokal Büyüklüğü
3. N Evresi — Lenf Bezi Tutulumu
4. A Evresi — Anatomik Yayılım
5. 6th Evre — Genel Hastalık Evresi
6. Grade (Histolojik Derece)
7. Diferansiyasyon
8. Östrojen ve Progesteron Reseptörleri
9. Lenf Nodu Analizi
10. Genel Değerlendirme & Özet

1. Tümör Boyutu

Tümör boyutu nedir?

Tümör boyutu, kanser kitlesinin milimetre (mm) cinsinden ölçülen fiziksel büyüklüğüdür. Bu ölçüm cerrahi sonrası patoloji laboratuvarında veya görüntüleme yöntemleriyle (ultrason, MR, mamografi) elde edilir. Boyut; evre belirleme, cerrahi planlama ve tedavi seçiminde kritik rol oynar.

Referans büyüklükler:

Boyut Aralığı	Karşılaştırma	Klinik Önemi
< 5 mm	Bir mercimek tanesi	Mikrokanser — çok erken
5-10 mm	Bir nohut	Evre T1a/T1b
10-20 mm	Bir üzüm tanesi	Evre T1c
20-50 mm	Bir fındık / ceviz	Evre T2
> 50 mm	Bir golf topu	Evre T3

Bu hastada ölçülen değer: 25 mm — Bu boyut T1 evresinin üst sınırında, T2'ye geçiş noktasındadır. Tek basına değerlendirildiğinde erken evre kapsamındadır.

2. T Evresi — Tümörün Lokal Büyüklüğü

T Evresi ne anlama gelir?

TNM evreleme sisteminin birinci bileşeni olan T (Tumor), kanserin yalnızca birincil olduğu yerde — meme dokusunda — ne kadar büyüdüğünü ve çevresine ne kadar yayıldığını tanımlar. Ameliyat veya biyopsi sonrası patoloji raporunda belirlenir.

Evre	Kriter	Acıklama
Tis	In situ	Kanser hücreleri henüz yayılmamış, sadece kanalda/lobulde sınırlı.
T1	<= 20 mm	Küçük, sınırlı tümör. 3 alt grubu var: T1a (<5mm), T1b (5-10mm), T1c (10-20mm).
T2	20-50 mm	Orta büyüklükte tümör, hâlâ meme içinde sınırlı.
T3	> 50 mm	Büyük tümör, ancak henüz cilt veya göğüs duvarına yapışmamış.

T4	Her boyut + yayılım	Cilde, göğüs duvarına veya her ikisine yayılmış ilerlemiş tümör.
-----------	---------------------	--

Bu hastada: T1 — Tümör 25 mm olmasına rağmen T1c alt grubuna girmektedir. Bu, en iyi prognostik kategoridir; cerrahi olarak tam çıkarma oranı yüksektir.

3. N Evresi — Lenf Bezi Tutulumu

Lenf sistemi nedir?

Lenf sistemi, vücutta bağışık sisteminin bir parçasıdır. Kanser hücreleri birincil tümörden ayrılarak önce en yakın lenf bezlerine (meme kanseri için genellikle koltuk altı — aksiller lenf bezleri) tasimabilir. N evresi, bu bezlerin kanser tarafından ne kadar tutulduğunu gösterir.

Evre	Tanim	Klinik Önemi
N0	Sifir lenf bezi tutulumu	En iyi senaryo — kanser henüz yayılmamış.
N1	1-3 koltuk altı lenf bezi pozitif	Sinirli yayılım; tedaviye iyi yanıt verir.
N2	4-9 lenf bezi veya iç meme lenf bezleri	İlerlemiş bölgesel yayılım.
N3	>= 10 lenf bezi veya köprücük kemigi üstü	Kapsamlı bölgesel yayılım, agresif tedavi gerektirir.

Bu hastada: N1 — 10 incelenen lenf bezinden 2'si pozitif çıkmış. Bu, sinirli bölgesel yayılım anlamına gelir ve standart tedavi protokollerine iyi yanıt veren bir kategoridir. Koltuk altı lenf bezi temizliği (aksiller diseksiyon) veya sentinel lenf bezi biopsisi tedavi planına dahil edilir.

4. A Evresi — Anatmik Yayılım

Anatomik yayılım nedir?

A evresi (SEER — Surveillance, Epidemiology and End Results sisteminden gelir), tümörün vücutta nerede olduğunu geniş bir perspektiften tanımlar. Uzak organlara (akciger, karaciger, kemik) metastaz yapılıp yapılmadığını gösterir.

Evre	Anlami	Prognoz
Lokalize	Yalnızca meme dokusunda sinirli	5 yıllık hayatta kalma > %98

Regional	Yakin lenf bezlerine yayilmis, uzak metastaz yok	5 yillik hayatta kalma ~%86
Distant	Uzak organlara (akciger, kemik, karaciger) metastaz	5 yillik hayatta kalma ~%28

* Hayatta kalma istatistikleri genel popülasyon verilerine dayanmaktadır; bireysel durumlar farklılık gösterebilir.

Bu hastada: Regional — Kanser yakin lenf bezlerine hafifçe yayilmis, ancak uzak organlara metastaz bulgusu yok. Bu, tedavinin hâlâ kür (tam iyilesme) amaci güdebildigi anlamina gelir.

5. 6th Evre (AJCC) — Genel Hastalik Evresi

Genel evre nasıl belirlenir?

AJCC (American Joint Committee on Cancer) 6. baskisi; T, N ve M (uzak metastaz) degerlerini bir araya getirerek hastaya tek bir evre numarası verir. Bu numara tedavi protokolünün belkemiğini olusturur.

AJCC Evresi	Tipik TNM Kombinasyonu	Genel Anlami
0	Tis N0 M0	In situ — henüz kanser degil, öncü lezyon
I	T1 N0 M0	Küçük tümör, lenf bezi yok, metastaz yok
IIA	T1 N1 M0 veya T2 N0 M0	Erken-orta evre; sinirli lenf tutulumu var
IIB	T2 N1 M0 veya T3 N0 M0	Orta evre; büyük tümör veya daha fazla lenf
IIIA	T3 N1-2 M0	İlerlemiş lokal hastalık
IIIC	Her T, N3 M0	Kapsamli bölgesel yayılım
IV	Her T, Her N, M1	Uzak metastaz — palyatif tedavi aşaması

Bu hastada: IIA — T1 N1 M0 kombinasyonu. Erken-orta evre; lenf bezine sinirli yayılım var ancak uzak metastaz yok. Bu evrede standart tedavi cerrahi + radyoterapi + sistemik tedavi kombinasyonudur ve kür oranı yüksektir.

6. Grade (Histolojik Derece)

Grade nedir?

Grade, patoloğun mikroskop altında kanser hücrelerini inceleyerek verilen bir puandır. Hücrelerin normal meme dokusuna ne kadar benzediğini ve ne hızda çoğaldığını gösterir. Nottingham Grading Sistemi (NGS) kullanılır; 3 kriter değerlendirilir: tübül oluşumu, nükleer pleomorfizm ve mitoz sayısı.

Grade	Mikroskopik Özellik	Büyüme Hizi	Tedaviye Yanıt
1 (Düşük)	Normal hücrelere çok benziyor	Yavaş	Hormon tedavisine iyi yanıt
2 (Orta)	Kismen farklılaşmış hücreler	Orta	Karma tedavi gerekebilir
3 (Yüksek)	Normal hücrelerden çok farklı	Hızlı	Kemoterapi öncelikli

Bu hastada: Grade 1 — Hücreler hâlâ normal meme hücrelerine çok benziyor, mitoz (bölünme) hızı düşük. En iyi prognoz kategorisi. Hormon reseptör tedavilerine yanıt verme ihtimali yüksek.

7. Diferansiyasyon

Diferansiyasyon nedir?

Diferansiyasyon, kanser hücrelerinin köken aldığı normal hücrelere ne kadar benzediğini tanımlar. Grade ile eş anlamlı kullanılır; patoloji raporlarında farklı terminoloji olarak karşımıza çıkar. Hücre ne kadar 'diferansiye' ise, o kadar normal davranır ve o kadar yavaş büyür.

Terim	Grade Karşılığı	Hücre Davranışı
Well Differentiated	Grade 1	Normal hücre görünümüne yakın, yavaş büyür, hormon duyarlı
Moderately Differentiated	Grade 2	Orta düzeyde farklılaşmış, orta hızda büyür
Poorly Differentiated	Grade 3	Çok farklılaşmış, agresif davranış, hızlı büyür
Undifferentiated	Grade 4	Köken hücreye hiç benzemiyor, en agresif form

Bu hastada: Well Differentiated — Hücreler hâlâ normal meme bezine benziyor. Bu durum hem yavaş ilerleme hem de hormona yanıt veren tedavilerin etkinliğini artırır. Grade 1 ile tam örtüşür.

8. Östrojen & Progesteron Reseptörleri (ER / PR)

Hormon reseptörleri neden önemlidir?

Bazı meme kanserleri büyümek ve cogalmak için östrojen veya progesteron hormonunu 'yakıt' olarak kullanır. Patoloji laboratuvarı, tümör hücrelerinin yüzeyinde bu hormonlara özel 'reseptör' (alici) proteini olup olmadığını immunohistokimya (IHC) yöntemiyle test eder.

Pozitif vs. Negatif:

Durum	Anlami	Tedavi Olanagi
ER+ / PR+	Tümör hormon reseptörü taşıyor	Tamoksifen, Aromataz inhibitörleri, Ovaryan supresyon — çok etkili hedefli tedavi
ER+ / PR-	Sadece östrojen reseptörü var	Hormon tedavisine kısmen yanıt verir
ER- / PR-	Hormon reseptörü yok (HR negatif)	Hormon tedavisi etkisiz; kemoterapi gerekir
Triple Negative	ER-, PR-, HER2- — üçü de negatif	En agresif tip; immunoterapi + kemo kombinasyonu

Tamoksifen nasıl çalışır?

Tamoksifen, östrojen reseptörüne 'sahte anahtar' gibi bağlanır. Gerçek östrojenin reseptöre ulaşmasını ve tümörü beslemesini engeller. Pre-menopozal kadınlarda 5-10 yıl süre ile kullanılır. Post-menopozal kadınlarda genellikle aromataz inhibitörleri (anastrozol, letrozol) tercih edilir.

Bu hastada: ER Pozitif + PR Pozitif — Mükemmel bir durum! Tümör her iki hormon reseptörünü de taşıyor. Bu, hormon supresyon tedavisinin son derece etkili olacağı anlamına gelir. Hedefli ve yan etkisi nispeten düşük bir tedavi yolu sunulabilir.

9. Lenf Nodu Analizi

Lenf nodu analizi neden yapılır?

Meme kanseri ameliyatında cerrah, tümörün yakınındaki lenf bezlerini (genellikle koltuk altı — aksiller bölge) çıkarır ve patoloji laboratuvarına gönderir. Bu inceleme, kanserin ne kadar yayıldığını göstermek açısından evrelemenin temel taşlarından biridir.

Bu hasta için veriler:

Gösterge	Değer	Yorumu
İncelenen Lenf Nodu	10	Cerrah 10 adet lenf bezi çıkarmış ve patologa göndermiş.
Pozitif Lenf Nodu	2	10 bezden 2'sinde kanser hücresi tespit edilmiş. Bu N1 evresine karşılık gelir.
Negatif Lenf Nodu	8	Kalan 8 bez temiz — iyi prognostik isarettir.
Pozitiflik Oranı	%20	Her 5 bezden 1'i tutulmuş; düşük-orta yayılım kategorisi.

Sentinel lenf bezi biopsisi nedir?

Günümüzde tüm lenf bezleri yerine sadece 'sentinel' (ilk drenaj noktası) bez çıkarılarak test edilir. Eğer sentinel bez temizse diğer bezler de büyük olasılıkla temizdir ve daha kapsamlı cerrahiye gerek kalmaz. Bu yöntem yan etkileri (özellikle lenfödemi) önemli ölçüde azaltır.

Bu hastada 10 bezden 2'sinin pozitif olması, sınırlı yayılımı teyit eder. Aksiller radyoterapi veya diseksiyona ek olarak sistemik tedavi (hormon supresyonu + muhtemelen kemoterapi) planlanabilir.

10. Genel Değerlendirme & Özet

Tüm verilerin bir arada değerlendirilmesi:

Parametre	Değer	Yorum	
Tümör Boyutu	25 mm	Küçük-orta, cerrahi açıdan uygun	OK
T Evresi	T1	En iyi lokal evre grubu	OK
N Evresi	N1	Sınırlı lenf yayılımı	~
A Evresi	Regional	Uzak metastaz yok	OK

AJCC Evre	IIA	Erken-orta evre, kür hedeflenebilir	OK
Grade	1	Yavaş büyüyen, düşük agresiflik	OK
Diferansiyasyon	Well	Normal hücreye benziyor	OK
ER / PR	Pozitif / Pozitif	Hedefli hormon tedavisi mümkün	OK
Lenf Nodu	2/10	Sinirli yayılım — bölgesel tedavi gerekli	~

Klinik Değerlendirme:

Bu hastanın profili son derece olumludur. Küçük tümör, erken evre, düşük grade, hormon reseptör pozitiflik ve sinirli lenf yayılımı kombinasyonu; bu kanserin 'en iyi tedavi edilebilir' kategorisinde yer aldığını gösterir. Standart tedavi yaklaşımları: Cerrahi (lumpektomi veya mastektomi), Radyoterapi (özellikle lumpektomi sonrası), Hormon tedavisi (Tamoksifen veya aromataz inhibitörü — 5-10 yıl), Kemoterapi (Oncotype DX skoru yüksekse değerlendirilebilir).

ÖNEMLİ UYARI: Bu belge yalnızca bilgilendirme ve eğitim amaçlıdır. Tani, tedavi kararı ve ilaç seçimi konularında mutlaka uzman bir hekim ile görüşülmelidir. Bireysel tıbbi kararlar bu belgeden hareketle alınamaz.